



Irradiados

Sobre hemocomponentes que contienen derivados celulares como Glóbulos Rojos y Plaquetas

Evita la ocurrencia de reacción injerto contra huésped por transfusión. Se logra con la irradiación sobre los linfocitos T que pasan al receptor, impidiendo su potencial proliferativo

¡No reemplaza a la filtración!

Indicaciones:

- Receptores de trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas durante el periodo de condicionamiento y mientras duren las profilaxis postrasplante para enfermedad injerto contra huésped.
- Pacientes con trasplante autólogo de médula ósea desde el condicionamiento hasta 3 meses postrasplante.
- Pacientes con enfermedades hematopoyéticas que recibirán inminentemente trasplante de médula ósea
- Linfoma de Hodgkin (LH)
- Déficit congénito de inmunidad celular
- Pacientes con anemia aplásica tratados con globulina antitimocito
- Pacientes tratados con análogos de purinas (fludarabina, cladribine, deoxycobormicina)
- Receptores de transfusiones de familiares directos (1er y 2do grado)
- Receptores de donantes HLA compatible
- Cánceres hematológicos distinto al LH (indicación débil)

*En pacientes con trasplante de órgano sólido no está recomendada de rutina la irradiación

